Acute Rheumatic Fever *& RHD*

Comprehensive Reference on Predisposing Factors (5–15 Years), Pathology (Aschoff Bodies), Jones Criteria (1944, Modified by AHA 1992 & Reconfirmed 2003), Major Criteria (Carditis 50%–70%, Arthritis 35%–66%, Sydenham Chorea 10%–30% / 15%, Subcutaneous Nodules 10%, Erythema Marginatum 5%), Minor Criteria & Acute Phase Reactants, Preceding GABHS Evidence, Clinical Course, Investigations, Treatment, and Secondary Prophylaxis.

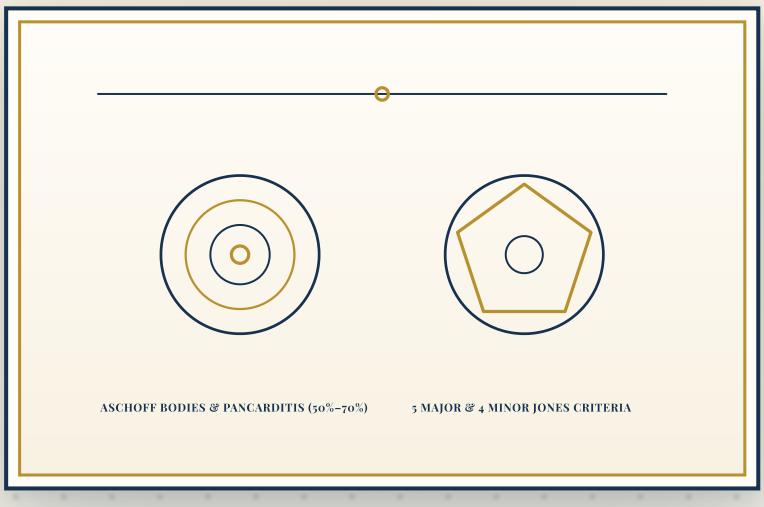


PLATE I — *Concentric involvement of the endocardium, myocardium, and pericardium (pancarditis) with pathognomonic Aschoff bodies (left), paired with the five major Jones criteria of Acute Rheumatic Fever (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة **الحمى الروماتيزمية الحادة وأمراض القلب الروماتيزمية (Acute Rheumatic Fever & RHD)** بالكامل طبقًا للنص الرسمي حرفيًا، شاملًا معايير جونز (Jones Criteria)، والجرعات العلاجية، وبروتوكول الوقاية الثانوية.

1. Predisposing Factors, Pathology & Overview of Jones Criteria

1. Predisposing Factors & Pathology of Rheumatic Fever

PREDISPOSING FACTORS OF RHEUMATIC FEVER

- **Family history** of rheumatic fever.
- **Low socioeconomic status: poor housing, bad nutritional status**.
- **Age:** between **5 – 15 Years**.

PATHOLOGY OF RHEUMATIC FEVER (ASCHOFF BODIES)

- **Characteristic lesion:** The characteristic lesion of rheumatic fever is **ASCHOFF bodies**.
- **Histological Composition:** Formed of **lymphocytes, plasma cells, certain macrophages** with **swelling and fragmentation of collagen fibers**.
- **Anatomical Distribution:** They are present in the **heart, joints, basal ganglia and skin**.

2. Historical Evolution & Classification of Jones Criteria of ARF

Jones Criteria of ARF (1944 → 1992 → 2003):
The Jones criteria, used for guidance in the diagnosis of ARF since **1944**, were last modified by the **American Heart Association (AHA) in 1992**. They were reconfirmed in principle at an **AHA-sponsored workshop in 2003** and historically have represented the clinical standard to establish the diagnosis of ARF.

MAJOR JONES CRITERIA OF ARF (WITH INCIDENCE %)	MINOR JONES CRITERIA OF ARF	MANDATORY SUPPORTING EVIDENCE
1. **Carditis** (50% – 70%) 2. **Arthritis** (35% – 66%) 3. **Chorea** (10% – 30%; *15% of ARF*) 4. **Subcutaneous nodules** (10%) 5. **Erythema marginatum** (5%)	— **Clinical:** · **Fever** · **Arthralgia / Polyarthralgia** — **Laboratory & ECG:** · **PR prolongation** (Prolonged PR interval) · **Acute phase reactants: Leucocytosis, High ESR, CRP**	+ **Evidence of recent (preceding) Group A β-hemolytic streptococcal (GABHS) infection**: — **Diagnosis of ARF 1st Attack:** · **Two Major criteria**, OR · **One Major and 2 Minor criteria** · **Plus** evidence of recent streptococcal infection.

العوامل المهيئة، الباثولوجيا (أجسام آشوف)، ونظرة عامة على معايير جونز (Jones Criteria):

• **العوامل المهيئة والباثولوجيا:** تشمل التاريخ العائلي للحمى الروماتيزمية، انخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي (سوء السكن وسوء التغذية)، والعمر بين **5 إلى 15 سنة**. الآفة الباثولوجية المميزة هي **أجسام آشوف (Aschoff bodies)** وتتكون من خلايا ليمفاوية، خلايا بلازمية، وبعض الخلايا البلعمية مع تورم وتكسر ألياف الكولاجين، وتوجد في **القلب، المفاصل، العقد القاعدية بالمخ (Basal ganglia)، والجلد.**

• **معايير جونز (Jones Criteria):** وضعت عام **1944**، وعدلت بواسطة جمعية القلب الأمريكية (AHA) عام **1992** وأُعيد تأكيدها عام **2003**. يُشخص الهجوم الأول بوجود **معيارين كبيرين (2 Major)** أو **معيار كبير ومعيارين صغيرين (1 Major + 2 Minor)** بالإضافة إلى **دليل على عدوى حديثة بالميكروب السبحي.**

2. Clinical Features of the Five Major Jones Criteria

1. Rheumatic Carditis (50%–70%) & Rheumatic Arthritis (35%–66%)

1) RHEUMATIC CARDITIS (50%–70%)

— **Pathological Scope:** It is **pancarditis** and can involve the **endocardium, myocardium, and pericardium**.

— **Clinical Presentation:**
· **Tachycardia out of proportion of fever**.
· **Muffled heart sounds**.

2) FEATURES OF RHEUMATIC ARTHRITIS (35%–66%)

— **Pattern: Migratory polyarthritis.**

— **Joints Involved: Larger ones, including knees, ankles, elbows, and wrists.**

— **Therapeutic Response: Rapid improvement with salicylates or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).**

— **Natural Course: Self-limited course, even without therapy, lasting ≈ 4 weeks.**

2. Sydenham Chorea (10%–30% / 15%), Erythema Marginatum (5%) & Subcutaneous Nodules (10%)

3) SYDENHAM CHOREA (10%–30% / 15%)

— **Incidence & Age/Sex: 15% of ARF** (range 10%–30%); **Female 8–12 y**.

— **Motor Features: Purposeless, involuntary, non-stereotypical movements of the trunk or extremities**.

— **Associated Signs: Muscle weakness** and **emotional lability**.

— **Latent Period Note:** Evidence of a recent group A streptococcal infection may be **difficult or impossible to document** because of the **long latent period** between the inciting streptococcal infection and the onset of chorea.

4) ERYTHEMA MARGINATUM (5%)

— **Morphology:** Unique **pink rash** seen with **pale centers** and **rounded or serpiginous margins**.

— **Distribution:** Usually present on the **trunk and proximal extremities** and is **not facial**.

— **Physical Properties: Heat can induce its appearance**, and it **blanches with pressure**.

5) SUBCUTANEOUS NODULES (10%)

— **Morphology & Size: Firm, painless protuberances** from **0.2 – 2 cm in diameter**.

— **Distribution:** Located on **extensor surfaces** at specific joints, including the **knees, elbows, and wrists**.

الخصائص الإكلينيكية للمعايير الخمسة الكبرى (Major Jones Criteria):
• **1. التهاب القلب الروماتيزمي (Carditis: 50%–70%):** هو التهاب شامل لطبقات القلب الثلاث **(Pancarditis: الشغاف، عضلة القلب، والتامور)**، ويظهر إكلينيكيًا بـ **تسارع ضربات القلب لا يتناسب مع درجة الحرارة وخفوت أصوات القلب (Muffled heart sounds)**.
• **2. التهاب المفاصل الروماتيزمي (Arthritis: 35%–66%):** التهاب مفاصل متعدد متنقل **(Migratory polyarthritis)** يصيب المفاصل الكبيرة (الركبتين، الكاحلين، المرفقين، والمعصمين)، ويستجيب بسرعة فائقة للأسبرين ومضادات الالتهاب (NSAIDs)، وهو ذاتي المحدودية يستمر حوالي **4 أسابيع** حتى بدون علاج.
• **3. كوريا سيدنهام (Sydenham Chorea: 15% [10%–30%]):** تصيب **الإناث (8–12 سنة)** وتظهر كحركات لاإرادية غير هادفة وغير نمطية بالجذع والأطراف مع **ضعف عضلي وتقلب انفعالي**، ويسبب إثبات العدوى السبحية السابقة لطول فترة الكمون.
• **4. الحمامى الهامشية (Erythema marginatum: 5%):** طفح وردي ذو مركز باهت وحواف دائرية أو متعرجة على الجذع والأطراف القريبة **(لا يصيب الوجه)**، يظهر بالحرارة ويختفي بالضغط.
• **5. العقيدات تحت الجلد (Subcutaneous nodules: 10%):** نتوءات صلبة غير مؤلمة بقطر **0.2–2 سم** على الأسطح الباسطة للمفاصل (الركبتين، المرفقين، والمعصمين).

3. Minor Criteria, Clinical Course & Investigations in ARF

1. Minor Jones Criteria, Acute Phase Reactants & Evidence of Preceding Streptococcal Infection

MINOR JONES CRITERIA & ACUTE PHASE REACTANTS

— **Clinical Minor Criteria: Arthralgia (Polyarthralgia), Fever**.

— **Lab / ECG Minor Criteria: Elevated acute phase reactants** (Leucocytosis, High ESR, CRP), **Prolonged PR interval**.

— **Acute Phase Reactants Cutoffs:**
· **ESR > 30–60 mm in the first hour** and **C-reactive protein (CRP) > 7.0 mg/dL** are considered typical of ARF.
· **Diagnostic Rule:** Normal ESR and C-reactive protein levels prompt serious reconsideration of the diagnosis of ARF, because **except for patients with isolated chorea, these values are almost never normal in ARF**.

EVIDENCE OF PRECEDING STREPTOCOCCAL INFECTION

— **1. Streptococcal Antibody Titers:**
· Increased or rising **anti-streptolysin O titer (ASOT)** or other streptococcal antibodies (**anti-DNase B**).
· **A rise in titer is better evidence than a single titer result**.

— **2. Microbiological Culture / Antigen:**
· A **positive throat culture for group A β-hemolytic streptococci**.
· Rapid antigen detection of streptococcal antigens.

2. Clinical Course of Acute Rheumatic Fever & Investigations in ARF

CLINICAL COURSE OF ACUTE RHEUMATIC FEVER

— **Carditis (Only cause of permanent damage):**
· **Only carditis can cause permanent cardiac damage**.
· Signs of **mild carditis disappear rapidly in weeks**, but **severe carditis may last for 2 to 6 months**.

— **Arthritis:**
· Subsides within **a few days to several weeks**, and **doesn't cause permanent damage**.

— **Chorea:**
· Gradually subsides in **6–7 months or longer** and **doesn't cause permanent neurological sequelae**.

INVESTIGATIONS IN ARF

— **1. Laboratory:**
· **Throat cultures**
· **Rapid antigen detection** of streptococcal antigens
· **ASOT**
· **Acute phase reactants** (Leucocytosis, ESR, CRP).

— **2. ECG:**
· **Prolonged PR, tachycardia, arrhythmias**.

— **3. Echocardiography:**
· **Acute valvulitis, types of valves, chamber dilatation**.

المعايير الصغرى، دلائل العدوى السبحية، المسار الإكلينيكي، والفحوصات:
• **المعايير الصغرى ومتفاعلات الطور الحاد:** تشمل إكلينيكيًا **الحمى وألم المفاصل (Arthralgia)**، ومعمليًا/تخطيطيًا **إطالة فترة PR** وارتفاع متفاعلات الطور الحاد **(ESR > 30 mm في الساعة الأولى، وCRP > 7.0 mg/dL)**. إذا كانت قيم ESR وCRP طبيعية فيجب إعادة النظر بشدة في التشخيص لأنها لا تكون طبيعية أبدًا في الحمى الروماتيزمية **إلا في حالات الكوريا المعزولة (Isolated chorea)**.
• **المسار الإكلينيكي والفحوصات: التهاب القلب (Carditis) هو الوحيد الذي يسبب تلفًا دائمًا بالقلب** (يختفي الخفيف في أسابيع، والشديد يستمر **2–6 شهور**)، بينما يختفي التهاب المفاصل خلال أيام إلى أسابيع دون تلف دائم، وتختفي الكوريا تدريجيًا خلال **6–7 شهور أو أكثر** دون مضاعفات عصبية دائمة.

4. Treatment of ARF & Secondary Prophylaxis of RHD

1. Eradication of Streptococcal Infection, Anti-Inflammatory Therapy & Chorea Treatment

1) ERADICATE STREPTOCOCCAL INFECTION & BED REST

— **Primary Eradication of GABHS Pharyngitis:**
· **Oral (PO) penicillin V for 10 days** remains the drug of choice for treatment of GABHS pharyngitis, **but ampicillin and amoxicillin are equally effective**.
· **If allergic to penicillin:** administer **erythromycin or clarithromycin for 10 days**, or **azithromycin for 5 days**.

— **Bed Rest & Activity Restriction:**
· Initially, patients should be placed on **bed rest** followed by a period of **indoor activity**.
· **Full activity should not be allowed until the acute phase reactants have returned to normal levels**.

2) ANTI-INFLAMMATORY REGIMENS & CHOREA MANAGEMENT

— **Aspirin & Corticosteroid Protocols in ARF:**
· **Aspirin in arthritis: 100 mg/kg/d for 2 weeks** — gradual withdrawal over **2–3 weeks**.
· **In mild and moderate carditis:** continue **aspirin 4–8 weeks** according to response and withdraw over **4–6 weeks**.
· **Severe carditis: prednisone 2 mg/kg/d for 2–6 weeks** — withdraw gradually with **aspirin 75 mg/kg/d to prevent rebound**.
· **Treatment of heart failure**.

— **Treatment of Rheumatic Chorea:**
· **Reduce physical and emotional stress**.
· **Severe cases: phenobarbital, Haloperidol, steroids**.

2. Secondary Prophylaxis of RHD: Medication Regimens & Duration

PROPHYLAXIS REGIMEN	DOSE, ROUTE & INDICATION
IM Benzathine Penicillin G	**0.6 – 1.2 million units IM every 2 weeks** in areas where rheumatic fever is endemic, in patients with residual carditis, and in high-risk patients.
Oral Penicillin	**50 mg BID** (twice daily).
Oral Sulfadiazine	—
Oral Erythromycin	**250 mg BID**.

CLINICAL CATEGORY	DURATION OF SECONDARY PROPHYLAXIS OF RF
No cardiac affection	**To 18 Years** or **at least 5 years following 1st attack**.
Documented carditis	**To 25 years** and often longer **till 40 years**.
Chronic carditis & artificial valve	**For life** (مدى الحياة).

علاج الحمى الروماتيزمية الحادة (Treatment of ARF) والوقاية الثانوية (Secondary Prophylaxis):
• **القضاء على الميكروب السبحي والراحة:** يُعطى **Penicillin V بالفم لمدة 10 أيام** (أو Ampicillin / Amoxicillin بنفس الكفاءة)، وللمرضى ذوي الحساسية للبنسلين يُعطى **Erythromycin أو Clarithromycin لمدة 10 أيام** أو **Azithromycin لمدة 5 أيام**. يلتزم المريض بالراحة التامة في الفراش ثم نشاط منزلي خفيف، ولا يُسمح بالنشاط الكامل إلا بعد عودة متفاعلات الطور الحاد (ESR, CRP) للمعدل الطبيعي.
• **العلاج المضاد للالتهاب وعلاج الكوريا:** في التهاب المفاصل يُعطى **Aspirin 100 mg/kg/d لمدة أسبوعين** ثم يُسحب تدريجيًا على **2–3 أسابيع**؛ وفي التهاب القلب الخفيف والمتوسط يستمر الأسبرين **4–8 أسابيع** ويُسحب على **4–6 أسابيع**؛ أما في التهاب القلب الشديد فيُعطى **Prednisone 2 mg/kg/d لمدة 2–6 أسابيع** ويُسحب تدريجيًا مع إدخال **Aspirin 75 mg/kg/d لمنع الارتداد (Rebound)**. تُعالج الكوريا بتقليل التوتر البدني والانفعالي، وفي الحالات الشديدة **Phenobarbital أو Haloperidol أو Steroids**.
• **الوقاية الثانوية ومدتها: Benzathine penicillin G بجرعة 0.6–1.2 مليون وحدة عضليًا كل أسبوعين** (أو بنسلين فموي 50 مجم مرتين يوميًا، أو سلفاديازين، أو

إريثروميسين 250 مجم مرتين يوميا). تستمر الوقاية **بدون إصابة قلبية حتى 18 سنة أو 5 سنوات على الأقل** بعد الهجمة الأولى، ومع **التهاب القلب الموثق حتى 25 سنة ويمتد غالبا حتى 40 سنة**، ومع **التهاب القلب المزمن أو الصمام الصناعي مدى الحياة (For life)**.

5. Master Summary Table & Self-Evaluation Questions

1. Master Summary of the Five Major Jones Criteria of ARF

MAJOR CRITERION	INCIDENCE	KEY CLINICAL FEATURES	COURSE, SEQUELAE & SPECIFIC RX
Carditis	**50% – 70%**	**Pancarditis** (endocardium, myocardium, pericardium); tachycardia out of proportion to fever; muffled heart sounds	**Only criterion causing permanent damage**; mild resolves in wks (Aspirin 4–8w, taper 4–6w); severe lasts 2–6 mo (Prednisone 2 mg/kg/d 2–6w + Aspirin 75 mg/kg/d)
Arthritis	**35% – 66%**	**Migratory polyarthritis** of large joints (knees, ankles, elbows, wrists); dramatic response to salicylates/NSAIDs	Self-limited (≈ **4 weeks**); subsides in days to weeks with **no permanent joint damage**; Aspirin **100 mg/kg/d × 2w**, taper 2–3w
Sydenham Chorea	**10% – 30%** (*15% of ARF*)	**Female 8–12 y**; purposeless, involuntary, non-stereotypical trunk/limb movements + muscle weakness & emotional lability	Long latent period (strep evidence hard to document; ESR/CRP may be normal); subsides in **6–7 months** with **no permanent neuro sequelae**; rest, Phenobarbital, Haloperidol, steroids
Subcutaneous Nodules	**10%**	**Firm, painless protuberances (0.2–2 cm)** over extensor surfaces of knees, elbows, and wrists	—
Erythema Marginatum	**5%**	Unique **pink rash with pale centers & rounded/serpiginous margins** on trunk & proximal limbs (**not facial**); induced by heat, blanches with pressure	—

2. High-Yield Self-Evaluation Questions

ℹ️ **ملاحظة:** المحاضرة **مفيهاش أسئلة** — الأسئلة دي متعملة من محتوى المحاضرة للمراجعة.

1 **What is the pathognomonic histopathological lesion of Acute Rheumatic Fever, and where is it found?**

- ○ a. Caseating granulomas found exclusively in the lungs and lymph nodes
- ○ **b. Aschoff bodies (lymphocytes, plasma cells, macrophages with collagen fiber swelling/fragmentation) in the heart, joints, basal ganglia, and skin** ✓
- ○ c. Subepithelial IgG and C3 humps found in the renal glomeruli
- ○ d. Reed-Sternberg cells in the spleen and bone marrow

الإجابة الصحيحة: b — الآفة المميزة للحمى الروماتيزمية هي أجسام آشوف (Aschoff bodies) المكونة من خلايا ليمفاوية وبلازمية وبلعمية مع تورم وتكسر ألياف الكولاجين، وتوجد في القلب، المفاصل، العقد القاعدية (Basal ganglia)، والجلد.

2 **Which of the five Major Jones Criteria is the MOST common (50%–70%) and the ONLY manifestation capable of causing permanent organ damage?**

- ○ a. Migratory polyarthritis (35%–66%)
- ○ b. Sydenham chorea (10%–30%)
- ○ **c. Rheumatic Carditis / Pancarditis (50%–70%)** ✓
- ○ d. Erythema marginatum (5%)

الإجابة الصحيحة: c — التهاب القلب الروماتيزمي (Carditis: 50%–70%) هو الأكثر شيوعًا وهو الوحيد الذي يمكن أن يسبب تلفًا دائمًا بالقلب، بينما يشفى التهاب المفاصل والكوريا تمامًا دون أي تلف دائم.

3 **In which presentation of Acute Rheumatic Fever may ESR (> 30–60 mm/1st hr) and CRP (> 7.0 mg/dL) be normal and streptococcal infection difficult to document due to a long latent period?**

- ◯ a. Acute severe pancarditis with heart failure
- ◯ b. Acute migratory polyarthritis of the knees and ankles
- ◯ **c. Isolated Sydenham chorea (typically in females aged 8–12 years) ✓**
- ◯ d. Subcutaneous nodules over the elbows

الإجابة الصحيحة: c — باستثناء حالات الكوريا المعزولة (Isolated Sydenham chorea) لطول فترة الكمون، فإن قيم ESR وCRP لا تكون طبيعية أبدًا في الحمى الروماتيزمية الحادة.

4 **What is the anti-inflammatory regimen for a child with SEVERE rheumatic carditis versus arthritis alone?**

- ◯ a. Ibuprofen for 3 days in both conditions
- ◯ **b. Severe carditis: Prednisone 2 mg/kg/d for 2–6 weeks, withdrawn gradually with Aspirin 75 mg/kg/d to prevent rebound (Arthritis alone: Aspirin 100 mg/kg/d for 2w, withdrawn over 2–3w) ✓**
- ◯ c. IV Methylprednisolone for 1 year without aspirin
- ◯ d. Phenobarbital and Haloperidol for arthritis

الإجابة الصحيحة: b — في التهاب القلب الشديد يُعطى Prednisone 2 mg/kg/d لمدة 2–6 أسابيع ويُسحب تدريجيًا مع Aspirin 75 mg/kg/d لمنع الارتداد (Rebound)، بينما في التهاب المفاصل يُعطى Aspirin 100 mg/kg/d لمدة أسبوعين ويُسحب على 2–3 أسابيع.

5 **What is the recommended duration of secondary prophylaxis in a patient with (1) no cardiac affection, (2) documented carditis, and (3) chronic carditis or an artificial valve?**

- ◯ a. 1 year for all categories
- ◯ **b. No cardiac affection: to 18 yrs (or ≥ 5 yrs after 1st attack); Documented carditis: to 25 yrs (often till 40 yrs); Chronic carditis / artificial valve: for life ✓**
- ◯ c. Stop immediately once ESR normalizes
- ◯ d. To age 12 years in all patients

الإجابة الصحيحة: b — مدة الوقاية الثانوية: بدون إصابة قلبية حتى 18 سنة أو 5 سنوات على الأقل بعد الهجمة الأولى؛ ومع التهاب قلب موثق حتى 25 سنة ويمتد غالبًا حتى 40 سنة؛ ومع التهاب القلب المزمن أو الصمام الصناعي مدى الحياة (For life).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين